

10 - 01- TRAVAIL NORMAL - Pr. Bassir

Bonjour, aujourd'hui on va voir l'élément mécanique de l'accrochement. Dans ce cours, le travail normal, on va voir l'élément dynamique de l'accrochement. C'est les contractions utérines, le travail et l'activité de l'utérus qui est le contenant de ce fœtus.

L'accrochement c'est un ensemble de phénomènes qui ont pour conséquence la sortie de fœtus et de ses annexes hors des voies génitales maternelles à la fin de la grossesse. Deux phénomènes de l'accrochement, il y a le phénomène mécanique, c'est le passage et l'adaptation du mobile fœtal à travers la filière pelvigénitale et le phénomène dynamique qui met en jeu l'élément moteur, l'utérus, à travers des contractions utérines. Le déroulement de l'accrochement se fait en trois phases, ou bien en trois périodes.

La première période, c'est la période de l'effacement et de dilatation du corps de l'utérus. La deuxième période, c'est la sortie de fœtus et la troisième période, c'est la sortie des annexes. L'utérus gravide, comme rappel, a une spécificité.

Elle est constituée de trois parties, le corps utérin, là où siègent les contractions utérines à n'importe quel point, puis la propagation de ces contractions sur le segment inférieur et le col permettant l'effacement et la dilatation du col. Elle est constituée de trois couches, une couche externe constituée de fibres musculaires longitudinales, une couche moyenne qui est plexiforme, donc c'est des fibres musculaires qui sont chevauchées, et une couche interne qui est circulaire. Le col est mince et constitué de fibres circulaires.

C'est un obstacle à la sortie, donc il faut qu'il soit ouvert et effacé permettant la sortie de ce fœtus. Il est élastique mais le retour à la forme initiale est très lent permettant une dilatation progressive. Cette élasticité varie selon sa maturation et sa résistance.

Quand la pression intra-utérine augmente, les contractions agissent après distension du segment inférieur sur la zone de faiblesse utérine, qui est l'orifice interne du col, qui se dilate et commence à s'effacer en s'incorporant au segment inférieur. La transmission se fait directement à l'orifice externe qui, à son tour, se dilate permettant une dilatation complète du col. Un élément très important est le segment inférieur, c'est la transformation de l'isthme de l'utérus.

Sachant que l'anatomie d'un utérus normal, on a le corps de l'utérus en haut, on a le col utérin, et entre les deux il y a un petit pincement qu'on appelle l'isthme utérin. Ce petit pincement ou cette portion de l'utérus qui est l'isthme utérin, il se transforme à partir du sixième mois de grossesse pour devenir le segment inférieur. Et c'est à ce niveau, donc on a une couche musculaire qui est très fine, circulaire, et c'est à ce niveau que se fait l'accès arrière.

Pour le mobile fœtal, il appuie directement sur l'orifice interne du col. En cas de présentation d'histocycle, cet appui est perturbé et peut modifier la dilatation. Si on parle ici de présentation d'histocycle, par exemple en cas de présentation de siège, on n'a pas un appui très important sur

le col.

C'est pour ça qu'on appelle une présentation, on peut avoir des histocycles, ça peut expliquer les histocycles du col et du travail. Après rupture des membranes, le mobile fœtal est en appui direct sur le col et la diminution de la distension utérine favorise la rétraction des fibres utérines avec des contractions plus efficaces. Arrivons aux contractions utérines.

Il faut savoir que les fibres myométriales ont des propriétés. Ils sont élastiques permettant une extension et une rétraction. Ils sont toniques qui permettent de maintenir un état d'équilibre du tonus permanent.

Ils sont contractiles avec une augmentation du tonus passagère. Les contractions utérines apparaissent à partir du sixième mois de grossesse. Elles sont physiologiques et c'est ce qu'on appelle les contractions de Braxton X. Ces contractions sont brèves, de durée minimum et de durée très brève.

Elles sont peu intenses. Elles sont anarchiques, ça veut dire qu'elles n'apparaissent pas de façon régulière. On peut avoir une à deux contractions par jour, un jour sur deux.

D'une intensité, on peut la sentir comme des petites algies au niveau du bas du ventre comme la patiente, elle décrit ses contractions comme des 10 semaines. Elles sont capricieuses, indolores et elles sont inefficaces. Inefficaces, ça veut dire qu'elles ne permettent pas de déclencher un travail normal.

C'est ce qu'on appelle les contractions de Braxton X. Pour les contractions utérines, c'est le moteur de l'accouchement. Ils ont trois effets. Ils permettent d'augmenter la pression intra-utérine.

Ils permettent de faire un appui sur le col par l'intermédiaire de la poche des os ou la présentation. A chaque fois qu'on a la poche des os qui est conservée, il permet de faire l'appui sur ce col utérin. Mais si la poche est rompue, à ce moment c'est la présentation qui fait l'appui directement sur le col utérin.

Ils permettent de faire une traction directe sur le col par l'intermédiaire du segment inférieur et du raccourcissement des fibres utérines. Pour que ces contractions soient efficaces, il faut avoir un rythme et une intensité suffisantes pour obtenir une dilatation. Donc le tonus ou l'intensité doit être supérieur à 30 mmHg et le rythme c'est à peu près 11 à 12 par heure.

Au cours du travail, ces contractions sont caractérisées par le fait qu'elles sont intermittentes, c'est-à-dire rythmées avec relâchement. Donc on a contraction, relâchement, puis contraction, relâchement. Elles sont interfasiques, involontaires, progressives, dont l'intensité augmente au fur et à mesure qu'on avance dans le travail.

Elles sont douloureuses, intenses, régulières et efficaces. On parle d'efficacité quand ces contractions permettent d'assurer une dilatation du col et une expulsion de fœtus à travers le périmètre. Parmi les caractéristiques de ces contractions, c'est l'efficacité totale.

Les contractions sont efficaces, ça veut dire qu'elles permettent une amplification du segment inférieur, un col souple, un effacement et dilatation du col, une descente du mobile fœtal et la formation de la poche des os. Sur ce schéma, on a les spécificités des contractions utérines. Il faut savoir qu'entre deux contractions, il y a un relâchement.

Donc cet utérus garde un tonus de base, un minimum de contractilité des fibres musculaires. On parle d'intensité vraie, c'est la différence entre le maximum de la contraction et le tonus de base. Et l'intensité totale, c'est la totalité des contractions, ça veut dire l'intensité vraie, l'intensité ressentie des contractions et le tonus de base.

Le tonus de base est en moyenne de 10 mmHg. L'intensité maximale, c'est 50 mmHg. Les contractions deviennent douloureuses à partir de 25 mmHg.

Il devient perceptible à partir de 20 mmHg. La durée de ces contractions, c'est à peu près 60 secondes. L'intervalle entre les contractions, c'est 200 secondes.

Et la fréquence, c'est 3 à 5 contractions par minutes. Ici, c'est les caractéristiques d'une contraction au cours du travail. Une contraction efficace qui permet une dilatation du col.

Il faut avoir un tonus de base à 10 mmHg, pas plus. Si on a un tonus qui est supérieur à ce taux, on peut parler d'une hypertonie. Ce n'est pas bien et ça ne permet pas d'avancer dans le travail avec un risque important de rupture.

Il faut avoir une intensité de 50 mmHg, ni moins ni plus. Il faut qu'il y ait un relâchement entre les contractions. Avec une fréquence de 3 à 5 contractions par 10 minutes.

L'activité utérine globale, en unité mondiale idéale, c'est l'intensité. En mmHg, fois le nombre des contractions par 10 minutes. Une activité normale, c'est 75 unités au début du travail, et arrivant à 250 unités à la période d'expulsion.

Comment on peut savoir, on peut étudier ces contractions utérines ? Et donc, si on veut étudier les contractions, ça veut dire on veut évaluer les différents paramètres pour voir est-ce que ces contractions sont efficaces ou pas, ou bien est-ce qu'il y a une anomalie de la dynamique utérine. On peut l'évaluer de deux façons, soit par tocographie externe ou bien par tocographie interne. On commence par la tocographie externe, c'est une technique qui n'est pas invasive, qui est simple, quel que soit l'état du col et des membranes.

Il permet d'étudier la fréquence des contractions, ça veut dire le nombre de contractions par 2 minutes, et la durée de ces contractions, est-ce qu'il est prolongé ou pas. Mais comme

inconvenient, c'est qu'il ne permet pas d'étudier l'intensité ni le tonus de base de ces contractions. Et ces contractions peuvent être modifiées par les mouvements du bébé ou bien de la femme, et si la femme est obèse.

Et donc, c'est la façon à travers un capteur externe qui est posé au niveau du fond de l'utérus, donc repéré par la main de l'examineur. Donc c'est un petit appareil, c'est le même, on a deux capteurs, un capteur des contractions intervines et l'autre capteur, on le met dans l'air cardiaque pour détecter le rythme cardiaque du fœtus. D'accord? Et ça permet d'enregistrer les contractions, mais c'est surtout le nombre des contractions et la durée de ces contractions.

La deuxième façon d'explorer ces contractions, c'est la tachographie interne. Donc là, vous voyez le capteur interne. C'est une méthode qui est quand même complexe.

Ça nécessite que les membranes soient rompues avec un risque infectieux important. Comme avantage, c'est que cette méthode n'est pas influencée par les mouvements de la femme ou bien par l'obésité de la femme. Il permet d'avoir l'idée sur le tonus de base, sur l'intensité totale et l'intensité vraie, qui est l'intensité totale moins le tonus de base.

Il permet également d'étudier la fréquence et la forme des contractions utérines, est-ce qu'elles sont symétriques ou asymétriques. À savoir que l'activité utérine globale, c'est l'intensité vraie fois la fréquence des contractions. Et donc, ici, la topographie externe, comme on a vu, ne permet pas de donner une idée sur le tonus de base, mais plutôt sur l'amplitude.

Par contre, la topographie interne permet d'avoir une idée précise sur l'intensité totale. Donc, malheureusement, ce qui est pratiqué à l'hôpital ou au CHU, c'est la topographie externe. Rarement, il sont rares les services qui font la topographie interne.

Ça reste quand même la topographie interne un examen ou bien un moyen de surveillance quand même précieux, surtout si on a un utérus cicatriciel et on veut accepter un accouchement par voie basse. Donc, vraiment, c'est un outil indispensable si on veut accepter un accouchement par voie basse. Il permet de détecter le risque de rupture, de prérupture.

Donc, les paramètres qui peuvent être étudiés, c'est le tonus de base. Généralement, la dilatation entre 4 et 6 cm, le tonus varie de 6, plus ou moins 4. 6 en phase active de travail, c'est 8. Et il devient alarmant, c'est le supérieur à 20. L'intensité de la contraction en début de travail, début de la phase active, c'est 40.

Une dilatation entre 6 et 10 cm, c'est 50, plus ou moins 10. Et ça devient alarmant lorsqu'il est supérieur à 70 mmHg. La fréquence, en moyen, c'est 3 à 5 par 10 minutes.

La deuxième phase active du travail, c'est 3 à 6, contraction par 10 minutes. Et il devient, on parle d'hypersensitivité de fréquence, 6 supérieur à 7. La durée, en moyen, de 90 secondes. En phase active, deuxième phase active, c'est 90 secondes.

Et il devient alarmant lorsqu'il est prolongé, ça dépasse 120 secondes. La répétition de contraction de 45 secondes, toutes les 3 minutes, n'affecte pas un fœtus normal. Des contractions trop fréquentes ou trop lentes peuvent l'affecter.

Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir, lorsqu'on a des contractions utérines, on a une situation d'hypoxie. Donc il n'y a pas de passage d'oxygène vers le fœtus. Et donc, ce fœtus, au cours de la contraction, il va utiliser ses réserves.

Mais lorsque les contractions sont prolongées, donc il ne peut plus assurer un état des besoins en oxygène satisfaisant. S'ils sont prolongés, à ce moment-là, ça commence ce qu'on appelle l'état de souffrance fœtale. Donc il ne faut pas que les contractions soient trop longues.

Un placenta malvascularisé ne permet pas de supporter les contractions utérines. Également, un fœtus qui est tragique, en cas de retard de croissance intra-utérine, ne supporte pas de fortes contractions. Donc ces situations, généralement, ils donnent un état de souffrance fœtale chronique.

Et donc, lorsqu'on a des contractions qui sont trop longues, qui sont trop fréquentes, ça engendre une situation de souffrance fœtale aiguë qui va se greffer sur la souffrance chronique. Et donc ce fœtus, il devient plus fragile. Pour les agents modifiants, la contraction utérine.

Il y a des agents qui permettent ou qui renforcent les contractions utérines. Les agents chimiques, à savoir les oocytocytos, et principalement un produit qu'on utilise et qui est indispensable dans la salle d'accouchement, c'est le cytotocinon. C'est un analogue de l'hormone hypophysaire des récepteurs spécifiques.

Son action clinique, c'est d'aider les agents chimiques à modifier la contraction utérine. C'est une action qui est immédiate, mais une demi-vie qui est courte de 2 minutes. Ça veut dire qu'on peut déclencher un travail dans le but de renforcer les contractions utérines ou bien de les régulariser.

Mais sa demi-vie, elle est courte, donc à chaque fois qu'il y a un problème, soit une hypercymise, soit un état de souffrance fœtale. Une fois qu'on arrête la perfusion, 2 minutes et c'est bon, ça passe, il n'y a plus de cytotocinon. Il augmente la fréquence et l'intensité des contractions ainsi que le tonus de base.

La sensibilité utérine augmente avec le terme à partir de 20 semaines améliorées et surtout à partir de 30 semaines améliorées. Les précautions d'emploi, il n'y a pas de contre-indication, sauf des précautions d'emploi selon les conditions obstétricales. Un utérus cicatriciel, donc il faut éviter de ne pas l'utiliser.

En cas de présentation de siège, on peut l'utiliser, mais à dilatation complète, en période d'exclusion. Ou bien s'il y a un bassin rétréci, il faut l'utiliser, mais avec une surveillance très stricte. Il ne faut pas dépasser 150 unités, ou bien 30 à 40 000 unités par minute, en raison d'un

effet antidiurétique pouvant entraîner une intoxication à l'eau.

Pour les agents modifiant la contraction toujours, on a le méthyl ergobaldine, le méthargin. C'est un dérivé d'ergot du siècle, puissant, utérotonique, qui augmente le tonus de base. Jamais avant la vacuité utérine, on l'utilise après la vacuité utérine, et en injection intramusculaire.

Un autre agent sont les prostaglandins, donc ce sont des agents toujours qui renforcent les contractions utérines. Elle a une action locale sur la collagène du col, elle est efficace à tout âge de grossesse. Elle peut être utilisée en gel, malheureusement en comprimé, en injectable, malheureusement ce n'est pas disponible chez nous au Maroc, donc elle est en rupture.

Les agents physiques, donc la chaleur, un massage utérin, un corps étranger au niveau du col, et là on parle de corps étranger au niveau du col, quand on veut déclencher les contractions utérines. Donc soit en cas de mort fœtale, la plupart du temps on a une mort fœtale avant terme, donc on a envie de déclencher les contractions. On peut utiliser soit une sonde de folie, c'est la sonde urinaire, on introduit au niveau du col, on gamble le ballonnet et on fait une petite pression sur la sonde urinaire, donc ça permet un petit peu de déclencher ces contractions utérines.

Ou bien par des lamineuses, ce sont des plantes sous forme de lamelles qu'on introduit au niveau du col, il permet de déclencher le travail. Mais ces lamineuses ne sont pas disponibles chez nous, donc ce qu'on fait le plus, c'est la sonde de folie. La rupture des membranes, ou bien la sollicitation cervicale à travers la tête, la poche des os, la surdistension utérine également peuvent déclencher et renforcer ces contractions.

Pour les agents inhibant les contractions utérines, il y a les anesthésiques, l'anesthésie générale, l'arraché anesthésie. Pour les antispasmodiques, ils ont une action musculotrope ou bien du magnésium. Et un agent qui est très important, qui inhibe ces contractions, ce sont des tocoéthiques.

Ce sont des produits qu'on utilise dans le cas de menaces d'accouchement prématurée, à savoir des bêta-mimétiques, des alpha-bloquants, la progestérone et les anti-inflammatoires. Pour les anomalies des contractions utérines, il y a l'hypercontractibilité ou bien l'hypersynésie. Il peut être de fréquence lorsque les contractions supérieures à 6 contractions par dénom.

L'hypercontractibilité d'intensité, lorsque c'est supérieur à 80 mmHg, le tonus de base supérieur à 25, on parle d'une hypertonie. Ou bien on peut avoir une hypocontractibilité ou hyposynésie qui peut être de fréquence lorsque c'est inférieur à 2 contractions par dénom ou bien d'intensité. Les hyposynésies, ce sont les distocies dynamiques les plus fréquentes.

Ils se manifestent par des contractions régulières mais insuffisantes, en intensité lorsque c'est inférieur à 30 mmHg, en fréquence lorsque le nombre des contractions est inférieur à 2 minutes ou bien ils sont espacés de plus de 3 minutes, et en durée lorsque c'est inférieur à 70 secondes. Ce sont des anomalies qui peuvent être corrigées facilement par la perfusion de cytotocycle. Et là,

sur ce schéma, on peut voir une hyposynésie de fréquence lorsque le nombre de contractions est très minime ou bien la durée qui est minime ou bien une hyposynésie d'intensité, ça veut dire que l'intensité est minime.

On peut avoir les deux, ça veut dire une hyposynésie de fréquence et d'intensité, donc on appelle une hyposynésie mixte. Notre anomalie d'hyposynésie, elle peut être parfois primitive ou bien secondaire, à l'utilisation en excès de cytocycle, ça veut dire une patiente qui est admise en salle d'accouchement, on veut accélérer son travail, on va mettre une perfusion très importante de cytocycle. Lorsqu'on a une anomalie mécanique, ça veut dire une disproportion photopélvienne, soit un bassin qui est rétréci, incompatible avec l'accouchement, ou bien un gros bébé qui ne peut pas passer, et donc ça donne une hyposynésie.

Et d'ailleurs, si on a une hyposynésie, la première chose qu'il faut vérifier, c'est une anomalie mécanique, une disproportion photopélvienne. Un hématome rétroplacentaire qui se manifeste par un état d'hypertonie, donc il y a des contractions et il n'y a pas de relâchement entre les contractions, ça veut dire la maintenance, le maintien du rythme de base. Une infection amniocoréale, une chorioamniotite également peut donner un état d'hypersynésie.

Il y a deux types d'hypersynésie, l'hypersynésie d'intensité, lorsque l'intensité des contractions est supérieure à 70 mmHg, ou bien une hypertonie avec tonus de base qui est trop élevé, et l'hypersynésie de fréquence supérieure à 6 contractions par 10 minutes. Sur le schéma, on a une hypersynésie de fréquence, des contractions qui sont très rapprochées avec une durée qui est très prolongée, ou bien d'intensité, l'intensité qui est très importante, ou bien mixte en rouge, donc une hypersynésie à la fois de fréquence d'intensité, ou bien un état plutôt mixte en bleu, ou bien un état d'hypertonie en rouge avec une augmentation de tonus de base. L'hypotonie, ou bien la tonie utérine, il survient chez la grande multipart avec une diminution du tonus de base sous 5 mmHg, le plus souvent lors de la diésence ou après, et est dû à un épuisement musculaire.

Pour les étiologies des anomalies de la contraction utérine, les hypersynésies peuvent être d'origine médicamenteuse, un syndrome de lutte, donc c'est la disproportion phytopédiaire, un hématome rétroplacentaire, ou bien une infection amniotique, et les hyposynésies sont dues à un épuisement. La conduite à tenir devant des anomalies de contraction. Lorsqu'on a une hyposynésie, on peut corriger cette hyposynésie, soit de fréquence ou d'intensité, par la perfusion de cytocine.

Alors, en cas d'hypersynésie, il faut arrêter la perfusion de cytocine, si elle est déjà mise en place, mettre la patiente en décubitus latéral gauche avec une oxygénothérapie pour éviter une souffrance fœtale aiguë, et réexaminer le bassin. Donc le but, ou bien éliminer une disproportion phytopédiaire, donc faire l'examen du bassin, et voir si la hauteur est correcte, refaire une échographie pour avoir une estimation du poids fœtal. Si on a une hypersynésie, ou bien la présence de contraction avant-terme, on appelle ça menace d'accouchement prématuré, on peut

le corriger par l'éthocolytique.

L'amniotomie, elle libère des prostaglandines. L'amniotomie, c'est la rupture artificielle de la poche des os. Cette amniotomie permet de libérer des prostaglandines, donc on a vu que ces prostaglandines, elles renforcent les contractions utérines, et donc elles vont aller majorer, et en même temps, elles permettent d'appliquer la présentation sur les segments inférieurs.

L'évacuation du liquide amniotique permet à la présentation de s'appliquer contre le col. Classiquement, on réalise l'amniotomie dès que la présentation est fixée, vers 4-5 cm de dilatation. Un délai de moins 6 heures après l'amniotomie qui reste le premier traitement de la progression anormale, et un délai de moins 2 heures à débit maximal de la perfusion d'ocytocine pendant la phase active du travail semblant raisonnable avant d'envisager une césarienne pour stagnation de la dilatation.

Alors, pour étudier les phases ou bien les périodes de l'accouchement, la première partie de l'accouchement, c'est la dilatation et l'effacement. La deuxième partie, comme on a vu, c'est l'exclusion, et la troisième partie, c'est la délivrance. La première partie, c'est la dilatation et l'effacement.

Au cours de la grossesse, les contractions qui apparaissent à partir du sixième mois de Braxton X permettent de la formation du segment inférieur. Alors qu'au cours du travail, ils permettent l'effacement du col qui, sous raccourci en hauteur, s'intègre progressivement dans le segment inférieur, et il permet une dilatation du col qui passe de la peau du doigt à 1 cm jusqu'à dilatation complète. Chez la primipare, la dilatation essuie l'effacement, alors que chez la multipare, les deux se font en même temps.

Cliniquement, il faut une surveillance de la dilatation du col pendant le travail qui est rapportée par un document, ce qu'on appelle le partogramme, sur des courbes cervicométriques de Friedman. Le partogramme, on le retrouve dans tous les dossiers d'obstétrique. Il faut savoir que le dossier d'obstétrique, c'est un dossier unique.

Ce n'est pas la même chose que les dossiers qu'on trouve en chirurgie ou bien en médecine. Le dossier d'obstétrique, c'est un dossier qui comporte tous les éléments, donc l'identité de la patiente, les antécédents, la justice et la parité de cette patiente et l'examen à la démission et la surveillance qui va être notée sur ce partogramme. Alors, ce partogramme, il contient sur l'horizontale, le temps en heures et la verticale, c'est la dilatation du col en centimètres.

Il permet à chaque fois que la patiente, par exemple, rentre à 4 centimètres, on peut suivre cette patiente jusqu'à dilatation complète. Et donc, on a une phase de latence qui commence dès le début des contractions jusqu'à une dilatation de 2 centimètres et demi, maximum 3 centimètres. On appelle ça la phase de latence.

Une phase active, c'est la phase de rentrée active en travail à partir de 3 centimètres. Donc,

pendant la phase de latence, c'est une patiente qui va être gardée en salle d'expectante, donc pour surveillance. Alors, une fois élue à 3 centimètres, cette patiente sera admise à la salle d'accouchement.

Et donc, ce qu'on rapporte sur ce partogramme, c'est le score de Bishop. Donc, ce score, il se base sur la dilatation, sur l'effacement, la consistance, la position et la présentation. Et donc, il est noté de 0 à 3. Enfin, sur la dilatation, est-ce qu'il est fermé, est-ce qu'il est dilaté 2 centimètres, 4 centimètres, plus de 5 centimètres, l'effacement du col de 0 à 30%, c'est 0 jusqu'à 80%, c'est 3, la consistance de ce col, sa position, est-ce qu'il est postérieur, central et la présentation, est-ce qu'il est mobile, est-ce qu'il est amorcé, est-ce qu'il est engagé.

Donc, deux phases, comme j'ai dit, c'est la phase, la première phase, c'est la phase de latence qui contient, la première phase qui contient la phase de latence et la phase active et la deuxième phase, c'est la phase d'exclusion. Pour la phase de latence que j'ai dit, c'est la première, c'est le début des contractions jusqu'à une dilatation de 2 centimètres et demi à 3 centimètres. Donc, plus de 3 centimètres, on parle de phase active de travail.

Voilà, sur la même courbe, ça permet de déterminer la phase de latence et la phase active. Donc, la première phase du travail, la phase de latence, c'est la phase de dilatation cervicale, elle est très lente, du début du travail infraclinique jusqu'à dilatation de 3 centimètres. La durée chez la primipare, elle est de 9 heures, donc plus ou moins 20 heures, maximum c'est 20 heures, alors que chez la multipare, elle est au moyen de 5h30, 5h30 jusqu'à maximum c'est 14 heures.

La phase active de 3 centimètres jusqu'à dilatation complète, la durée en moyen est de 4 heures et ne doit pas dépasser 5 heures chez la primipare et 2h30 chez la multipare. Elle est divisée en phases d'accélération de 3 à 5 centimètres, qui est le meilleur indicateur de la dynamique utérine, elle est courte et variable. Et la phase de dilatation de 5 à 8-9 centimètres avec une vitesse moyenne de 1,2 centimètres chez la primipare et 1,5 centimètres chez la multipare.

On parle de dilatation stationnaire pendant cette période lorsqu'on a une stagnation du col de dilatation qui est supérieure à 2 heures. Et on a une phase de décélération de 8 à 9 centimètres jusqu'à dilatation complète. On enregistre un petit ralentissement de la vitesse des contractions et généralement ne doit pas dépasser 2 heures quelle que soit la parité.

Et la deuxième phase, c'est la phase d'expulsion. C'est la descente du mobilier foetal avec une dilatation complète, la poche des os doit être rompue. Et la durée en moyen c'est 1 heure chez la primipare et 30 à 40 minutes chez la multipare.

Alors ici, comme vous voyez, la phase de latence et il y a une différence de la phase active de la multipare qui est plus lente par rapport à la primipare qui est plus rapide. La courbe de dilatation qui permet de rapporter la dilatation, la descente de la présentation et le degré d'engagement. Donc lorsqu'il est engagé, elle est à plus 1, donc plus 1 ou plus 2. Et lorsqu'il n'est pas engagé, elle est à moins 1. Et la dilatation, l'évolution de la dilatation pendant la durée du travail.

Donc ça permet d'avoir une idée sur le sport de Bishop. La deuxième partie de l'accouchement, c'est la partie où il y a l'engagement du fœtus, la descente et l'expulsion de ce fœtus. Le partogramme, c'est un enregistrement graphique des progrès du travail et des principales données sur l'état de mère et de fœtus.

C'est un document médico-légal recommandé pour le dépistage et le diagnostic des dystussives. C'est un outil de sécurité pour l'obstétricien, pour également la sage-femme. Une méthode pour documenter graphiquement les examens vaginaux.

Elle diminue le risque de travail prolongé lors de l'utilisation du cytotec et le risque de césar. Sur le partogramme, on a la phase de latence. On rapporte la phase active jusqu'à l'expulsion du fœtus.

Ici, on a une image qui rapporte un petit exemple sur le partogramme, sur le dossier obstétrique. Également ici, la même chose que le partogramme. Un exemple de partogramme qui rapporte les différents éléments, la descente, l'engagement, l'épidermiotique, l'état du fœtus et tout ça.

Pour les anomalies des phases de travail. La phase de latence, on peut avoir soit un faux travail, soit une dystussive de démarrage. La différence entre faux travail et dystussive de démarrage, les deux, c'est avoir une phase de latence qui est prolongée par rapport à la normale.

La patiente rentre à un centimètre, à deux centimètres et il reste à deux centimètres. Il n'y a pas de rentrée dans la phase active du travail. Comment faire la différence pour le faux travail? Pour les deux, faux travail et dystussive de démarrage, on a des contractions éphémères.

Mais lorsqu'on a un faux travail, on peut lui donner des antispasmodiques ou des analgésiques et ce travail se calme. On parle de faux travail alors qu'en cas de dystussive de démarrage, lorsqu'on lui donne des antispasmodiques, il y a toujours des contractions. Ça n'agit pas sur les contractions, on a toujours des contractions éphémères qui persistent.

Et là, on parle de dystussive de démarrage. Pour la phase active, on peut avoir une stagnation de la dilatation. Lorsqu'il est supérieur à 12 heures, on a la même dilatation.

Ou bien on peut avoir un défaut d'engagement à dilatation complète. Dans les deux cas, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie mécanique, une disproportion fœto-pelvienne. Donc si on a une anomalie mécanique, avec une stagnation, il faut passer vers la césarienne.

S'il n'y a pas d'anomalie mécanique, à ce moment-là, voir s'il y a une anomalie dynamique, une hypocynésie ou bien une hypercynésie. Et à ce moment-là, on peut la corriger. La direction du travail, c'est l'ensemble des mesures mises en œuvre pour modifier le déroulement de l'accouchement.

Ne doit pas nuire ni au fœtus, ni à la mère. Elle engage la responsabilité de l'équipe médicale.

Parmi les moyens qui permettent de diriger le travail, c'est la rupture artificielle des membranes, l'oxytocine, l'analgésie péridurale, la position maternelle, l'accompagnement des patients.

Donc l'état psychologique, c'est très important. Il faut accompagner les patients, surtout les primipares. C'est leur première grossesse, donc ils n'ont jamais essayé des contractions éthérines, donc il faut les accompagner.

L'attitude de l'équipe médicale, donc il faut que l'équipe médicale soit patiente avec les perturbantes. Et les autres, la médecine alternative, la rotation manuelle et les présentations postérieures. Les dyslossies, toute anomalie dans la progression du travail se traduit par une stagnation de la dilatation et ou un arrêt de la progression.

Il peut être soit mécanique, donc toujours éliminer une cause mécanique. Je le dis et je le répète, une dysproportion plutôt peygane. Dynamique, une anomalie de l'activité utérine qui peut être corrigée.

Une anomalie cervicale qui peut être fonctionnelle ou bien mécanique. Et une anomalie des parties molles et un obstacle prévient. Donc une anomalie cervicale soit fonctionnelle ou mécanique, un code qui est rigide, qui ne se dilate pas.

Ou bien lors d'une colonisation ou une tumeur cervicale, donc qui peut poser un problème. Ou les parties molles et un obstacle prévient, une tumeur vaginale par exemple, un filtre vaginal qui peut entraîner ces dyslossies. Arrivons à la conclusion.

La connaissance de la physiologie de la contraction utérine permet de comprendre les anomalies du travail et de pouvoir les corriger. La qualité de la dilatation cervicale dépend de l'efficacité de la contraction utérine, mais aussi des éléments mécaniques de l'accouchement. Toute dyslossie dynamique peut cacher une dyslossie mécanique.

Il faut la corriger et penser à la dyslossie mécanique avant de corriger la dyslossie dynamique. Je vous remercie.